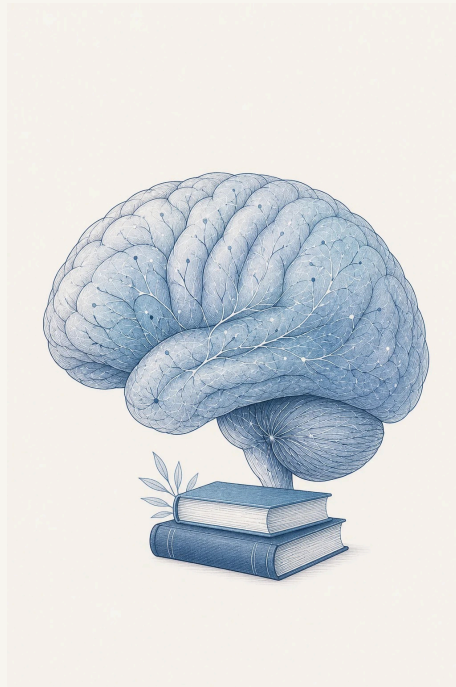


AMOSTRA GRATUITA · TRECHO DO GUIA

ROTEIRO PSIQUIÁTRICO

*Leia o Capítulo 1 — os princípios da entrevista,
com as dicas de como conduzir a escuta e
organizar o raciocínio.*



**Julia Assuçena Medrado Castro ·
Marina Araújo Silveira**

Médicas residentes em Psiquiatria

1

Princípios da entrevista psiquiátrica

Antes dos roteiros por transtorno, sete princípios de técnica que atravessam todos os capítulos deste livro.

O funil: do aberto ao fechado.

Toda investigação começa com pergunta aberta ("como anda seu ânimo?"), estreita para perguntas dirigidas ("isso acontece todo dia?") e só então fecha em critérios ("nas últimas duas semanas, na maior parte dos dias?"). Inverter o funil — abrir a consulta com checklist — produz respostas pobres e paciente passivo.

Âncoras de tempo e de fato.

Memória de sintoma é imprecisa. Ancore períodos em marcos da vida do paciente ("isso já era assim no Natal? antes ou depois de você perder o emprego?") e prefira fatos contáveis a rótulos ("quantas noites por semana", e não "você tem insônia?").

Normalizar antes de perguntar o difícil.

Temas que carregam vergonha — suicídio, violência, sexo, purgação, uso de drogas — entram melhor precedidos de uma frase que apresenta a experiência como humana e conhecida: "muita gente que passa pelo que você está passando tem pensamentos de desistir; aconteceu com você?".

Perguntar por comportamento, não por diagnóstico.

"Você tem compulsão?" rende menos que "o que acontece quando você abre um pacote de bolacha?". O paciente é especialista na própria vida, não na nossa nomenclatura.

A resposta vaga é um dado.

"Vou levando", "normal", "mais ou menos" pedem concretização: peça o filme de ontem, da hora de acordar à hora de dormir. Um dia descrito em detalhe vale mais que dez adjetivos.

O acompanhante é instrumento diagnóstico.

Em mania, demência, psicose e TDAH, o informante muda o diagnóstico. Mas defina momentos a sós com o paciente em toda avaliação — é onde aparecem violência doméstica, uso de substâncias e ideação suicida.

Anote as frases, não só os sintomas.

Registrar no prontuário as palavras exatas do paciente ("sinto um aperto que não desgruda") preserva informação psicopatológica que a tradução para jargão destrói — e protege você juridicamente em avaliações de risco.

PÉROLA CLÍNICA

A aliança vem antes do dado: paciente que se sente interrogado esconde; paciente que se sente compreendido conta. Se a entrevista travar, largue o roteiro e devolva o que ouviu: "deixa eu ver se entendi o que você está vivendo...". O roteiro serve à conversa, nunca o contrário.

VOCÊ LEU O CAPÍTULO 1

Este é só o começo do roteiro.

O guia completo traz o mesmo método aplicado **transtorno a transtorno**: depressão, bipolar, risco de suicídio, ansiedade, TOC, TEPT, álcool e substâncias, psicose, delirium, demência, transtornos alimentares, TDAH no adulto, sintomas somáticos e transtornos da personalidade.

- 16 capítulos + 3 apêndices práticos
- Exame do Estado Mental, checklists de consulta rápida e exemplos de registro clínico
- Caixas *Pérola clínica*, *Atenção* e *Como falar* em cada capítulo
- 86 páginas, em PDF pesquisável

Adquira o guia completo pelo link na bio das autoras.

Roteiro Psiquiátrico · guia prático de anamnese e exame do estado mental.
Material educacional para profissionais e estudantes da saúde.